

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	協助電氣痙攣治療 Assisting with Electroconvulsive Therapy ; ECT				
編號	A31000-Q05-W-B47	制定者	PSY 李家靜	公布日期	100 年 04 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 07 月 02 日
版本/總頁數	第 2.8 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 09 月 15 日

一、目的

護理人員能瞭解精神科常用的特殊肌體治療並協助進行。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 技術目的

改善對藥物治療無效的嚴重精神症狀、具有高度攻擊或自傷行為的精神疾病，包含重鬱症、思覺失調症、躁症、神經性厭食症、強迫症等。
高度自殺風險、重度憂鬱發作、其他治療療效不佳

(二) 用物準備

1. 治療室及平硬的治療床。
2. 急救車、電擊器、抽吸設備、鼻導管、三合一生理監視器、二氧化碳監測器。
3. 電氣痙攣治療儀器、連接線、金屬導電貼片 2 個、固定頭帶 1 條、導電用凝膠 1 瓶、導極貼片 9 個、壓舌板。
4. 藥物：Glycopyrolyn inj 0.2mg/ml/amp(減少唾液分泌)、Fresofol 1% 200mg/20ml/amp(短效之靜脈全身麻醉劑)、Lidocaine 2% 100mg/5ml/amp (由麻醉科醫師評估是否需要使用)，以上藥物皆由麻醉科醫師給予及評估使用劑量。

主題名稱	協助電氣痙攣治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B47	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	2/7

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. ECT 前之準備。	1. 由醫師向病人及家屬說明並簽妥電氣痙攣治療同意書。 2. 每次執行治療前須進行麻醉評估，並簽妥麻醉同意書及自費手術麻醉費同意書 3. 醫師開立 Electroconvulsive therapy 醫囑。 4. 病人需完成常規身體檢查、血液檢查、胸部 X 光、EKG、EEG 或其他個別性檢查，由醫師評估是否需進行 Brain CT、MRI，確認病人有無禁忌症。 5. 禁食 6-8 小時，治療前一晚須告知午夜後禁食。 6. 治療前一日，頭髮油膩者須洗頭髮，減少因油垢附著而增加電阻。 7. 建立靜脈輸液管路。
2. 核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
3. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋治療過程。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
4. 確認病人已禁食 6-8 小時。	預防治療中及治療後發生嘔吐致吸入性肺炎。
5. 提醒病人治療前先完成如廁排空膀胱。	排空膀胱及預防失禁。
6. 提醒勿化妝、口紅及擦指甲油。	避免影響末梢循環的評估。
7. 請病人穿著寬鬆舒適的衣服，取下活動假牙、眼鏡、髮夾、助聽器、手錶及其他金屬飾品。	
8. 病人進入治療室，協助病人平躺於治療床，連接三合一生理監視器及測量生命徵象、血氧濃度。	紀錄治療前生命徵象及血氧濃度。
9. 將壓舌板置於口內同一側犬齒至白齒部位，請病人輕咬住。	預防痙攣時咬傷舌頭或口腔軟組織。
10. 使用鼻導管，依醫囑給予氧氣 3L/min。	提供充分氧氣吸入，視情況可提高氧氣流量。
11. 拭淨額顳處皮膚，將 2 個金屬導電貼片塗上適量的凝膠，再以頭帶固定在兩側額顳處（額頭兩端與雙眉尾外上部位），接上連接線，並將 9 個導極貼片貼於適當部位。	1. 皮膚上的油垢會增加電阻，可用清水拭淨，或請病人於治療前洗臉。 2. 檢查連接線是否接妥。 3. 導極貼片各有其顏色及不同屬性，EEG×4（紅

主題名稱	協助電氣痙攣治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B47	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
	色×2:兩側眉心上方、黑色×2:兩耳後乳突處), EKG×3 (綠色接地線:左乳頭上、黑色:胸骨右側、紅色:心尖處), EMG×2 (咖啡色:左腓中間及下段)。
12. 麻醉科醫師以靜脈注射藥物: Glycopyrodyn inj 0.2mg/ml/amp IVP	1. 可減少呼吸道及唾液腺分泌、防止心跳過慢阻斷心臟迷走神經反射作用。 2. 此項藥物由麻醉科醫師評估使用劑量及是否需要注射。
13. 麻醉科醫師以靜脈注射給予所需藥物劑量: Fresofol 1% 200mg/20ml/amp。	此項藥物由麻醉科醫師評估使用劑量並注射。
14. 麻醉科醫師確認病人進入深沉睡眠, 若尚未入睡, 由麻醉科醫師評估續追加 Fresofol 劑量。	此時病人鼻息聲轉為深沉, 可叫喚拍打病人、給予痛刺激或撥弄睫毛無反應以確認。
15. 一位護理人員站於病人頭側, 兩手分別固定於病人之額頭及下顎處 (壓額抬頷)。	1. 使頸部微向後仰以保持呼吸道通暢。 2. 以手指頭維持壓舌板之固定位置。
16. 四位護理人員站於病人兩側協助固定病人雙側肩關節、肘關節、髖關節、膝關節。	預防痙攣時脫臼或骨折, 但勿強壓關節。
17. 精神科醫師操作儀器準備通電, 進行第一次電痙攣治療, 使電流通過腦部誘發大發作並計算發作時間與型態。	注意有無強直期及陣攣期出現, 若病人無反應則需檢視金屬導電貼片是否未貼牢或連接線鬆脫。
18. 病人第一次痙攣結束後, 維持呼吸道通暢, 確認生命徵象及末端吐氣二氧化碳指數 (ETCO ₂), 觀察呼吸型態、血氧濃度。	1. 紀錄第一次痙攣結束後生命徵象、血氧濃度。 2. 以壓額抬頷法維持呼吸道通暢, 確認生命徵象變化及自呼情形, 若分泌物較多, 視情形予以抽吸清除。
19. 休息一分鐘後, 麻醉科醫師再確認病人意識, 評估是否需給予 Fresofol 劑量。精神科醫師進行第二次電痙攣治療並計算發作時間與型態。	
20. 病人第二次痙攣結束, 維持呼吸道通暢, 確認生命徵象、血氧濃度及末端吐氣二氧化碳指數 (ETCO ₂), 觀察呼吸型態, 協助側臥, 取出壓舌板。	1. 若牙關緊閉致壓舌板無法取出, 待其放鬆再取, 勿強拔以免傷害牙齒及口腔軟組織。 2. 紀錄第二次痙攣結束後生命徵象。 3. 誘發兩次痙攣則此次治療結束; 若過程無發生痙攣, 最多只可進行四次電痙攣治療。
21. 若分泌物較多, 視情形使用抽吸設備清除。	避免分泌物阻塞呼吸道。
22. 持續監測意識狀態、生命徵象、血氧濃度, 注意有無併發症情形, 移除電痙攣治療所有貼片。	若意識改變、生命徵象不穩定, 立即告知醫師予以處置, 必要時實施急救。

主題名稱	協助電氣痙攣治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B47	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
23. 密切觀察病人，若意識尚未完全清醒，宜予陪伴並使用床欄，注意其安全。	
24. 記錄治療前、第一次痙攣結束、第二次痙攣結束的生命徵象、血氧濃度變化，治療結束後每 5 分鐘記錄生命徵象、血氧濃度變化且持續 30 分鐘。	1. 若生命徵象不穩定則持續監測。 2. 若當天有 2 位病人，則第一位病人推床至會談室持續觀察。
25. 病人清醒後歸還其所有物，確認無不適副作用，評估步態、平衡測試、四肢肌力，無不良反應再協助返回個人病室休息或提供飲水觀察吞嚥反應。	評估是否有副作用、口腔內咬傷或牙齒搖動情形。
26. 若病人有頭痛、肌肉酸痛、噁心或嘔吐，依醫囑予藥物緩解不適。	偶發性副作用。
27. 若有近期記憶喪失則予解釋告知此為常見的暫時現象，予同理以緩解其不安與焦慮。	暫時性的記憶力障礙通常會維持數日至 6 個月左右，依療程長短及個人狀況而定。
28. 將病人治療前、中、後的反應及主觀感受詳細紀錄。	
29. 執行電腦 HIS 系統於執行狀態點選“已執行”並計價。	

備註：

- 併發症：暫時性記憶力喪失、骨折或脫臼、呼吸暫停、頭暈、噁心、嘔吐、齒齦出血、肌肉酸痛、背部酸痛、短暫的心律不整等。
- 禁忌症：接受電氣痙攣療法時會引起腦壓忽然升高，故腦瘤、腦出血、腦膿瘍為絕對禁忌症；此療法時亦會增加心臟血管之負擔，故最近發生過心肌梗塞、心絞痛或心臟衰竭病人應避免；此外惡性高血壓、動脈瘤、視網膜剝離、慢性阻塞性肺疾病、發高燒、孕婦等亦宜避免。

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	協助電氣痙攣治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B47	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	5/7

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 邱照華(2018)·常見治療方式與護理·邱照華著，精神科實習手冊(二版，86-89 頁)·台北市：華杏。
- (二) 蘇淑芳(2010)·精神科常見技術·蕭淑珍總校閱，精神科護理概論-基本概念及臨床應用(八版，A-16－A-26 頁)·台北市：華杏。
- (三) 蕭淑貞等(2015)·附錄三精神科常見技術·技術 3·蕭淑貞總校閱，精神科護理概論-基本概念及臨床應用(九版，A-22－A-26 頁)·台北市：華杏。
- (四) 連寶珠、廖肇安、劉宜釗(2021)·肌體治療·於蕭淑貞總校閱，精神科護理學(十版，190-240 頁)·台北市：華杏。
- (五) 李晉邦(2022)·精神醫學的絕地武士～電痙攣治療·長庚醫訊，39(5)，159-161。

七、附件

(略)

主題名稱	協助電氣痙攣治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B47	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.04.06	1.0	新制定。	100 年 04 月 06 日 護理部技術標準委員會通過。
101.12.04	1.1	補充步驟 1 說明內容：核對電腦 HIS2008 系統（住院護理系統之 Assisting with Electroconvulsive therapy；ECT 醫囑）。	101 年 12 月 04 日 護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	2.1	1. 步驟 9 之說明增加：視情況可提高氧氣流量。 2. 步驟 20 修改為：治療前、治療後（痙攣結束時）、治療結束後 15 分鐘、30 分鐘測量生命徵象是否趨穩定；說明增加：若生命徵象不穩定則持續監測。	102 年 12 月 04 日 護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.09.16	2.2	說明(二)用物準備刪除：電擊貼片 2 個。新增：金屬導電貼片 2 個、固定頭帶 1 條、導電用凝膠 1 瓶等說明。	103 年 09 月 16 日 護理部技術標準委員會通過。
104.09.29	2.3	1. 第三項第(三)目說明內容部份刪修。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日 護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	2.4	修改第三項第(三)目之 3 病人辨識說明。	105 年 09 月 13 日 護理部技術標準委員會通過。
106.09.18	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	2.5	1. 第三項第一目精神分裂症更名為思覺失調症，新增強迫症。 2. 第三項第三目說明步驟之 5、11 內容部分修辭，之 12、14 要點說明內容部分修辭。 3. 第六項第二目參考資料文字修訂。	107 年 10 月 17 日 護理長會議通過。

主題名稱	協助電氣痙攣治療	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B47	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
108.11.05	2.6	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過;108 年 10 月 09 日護理長會議通過;108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.09.21	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.23	2.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	2.7	1. 第三項第二、三目內容部份刪修。 2. 第六項參考資料文獻部份新增。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過;111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.09.18	2.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.07.02	2.8	1. 第三項第一、二、三目內容部份刪修。 2. 第六項參考資料文獻更新。	113 年 06 月 17 日護理技術組會議通過; 113 年 07 月 02 日督導會議通過公布。
114.09.15	2.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	